Ficha Técnica: Conocimiento del Dominio y Contexto del Proyecto

Para organizar la información de manera clara y estructurada, se propone una *Ficha de Caracterización del Dominio*. Esta herramienta permite que el equipo defina el contexto del análisis, comprenda el problema y establezca un enfoque antes de comenzar el trabajo con los datos.

SECCIÓN	CAMPO DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN / REGISTRO DEL EQUIPO
Identificación	**Nombre del Proyecto**	*Título descriptivo del análisis.* **Infecciones respiratorias agudas en Argentina: cambios entre 2019 (prepandemia) y 2025 (pospandemia)** *Versión actualizada en el Sprint 2 (20/10/2026) a partir de la devolución docente.*
	Eje Temático	*Área general (ej. Salud, Finanzas, Medio Ambiente).* Salud pública – Vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias.
Contexto de análisis	**Descripción del análisis**	*¿Qué vamos a analizar?Describe el objeto/fenómeno* Se analizan las notificaciones de infecciones respiratorias agudas (IRA) registradas en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS): enfermedad tipo influenza (ETI), neumonía y bronquiolitis en menores de 2 años. El objetivo es describir qué cambió entre 2019 (antes de la pandemia de COVID-19) y 2025, dos años completos: qué eventos y grupos de edad concentran los cambios, en qué semanas empieza, alcanza su pico y termina la temporada, y qué provincias tienen mayor incidencia en relación con su población. Las IRA son una de las principales causas de consulta e internación, sobre todo en los meses fríos. La pandemia alteró la circulación de los virus respiratorios y los sistemas de vigilancia, por lo que interesa saber si el comportamiento actual es distinto al previo.
	Glosario de Términos	*Definición de conceptos clave para evitar ambigüedades.* • **IRA:** infecciones respiratorias agudas; agrupa los tres eventos analizados. • **ETI (enfermedad tipo influenza):** cuadro de aparición súbita con fiebre mayor a 38 °C y tos o dolor de garganta, sin otra causa que lo explique.

		• **Neumonía:** infección del tejido pulmonar, diagnosticada por la clínica y/o la radiografía. • **Bronquiolitis:** infección de las vías respiratorias pequeñas (bronquiolos) en menores de 2 años; la causa más frecuente es el VSR. • **VSR:** virus sincicial respiratorio. • **Notificación:** caso que un establecimiento de salud registró en el SNVS. No es un caso confirmado por laboratorio ni el total real de enfermos. • **Evento de notificación obligatoria:** enfermedad que los establecimientos deben informar por ley al sistema de vigilancia. • **SNVS 2.0:** sistema informático nacional donde se registran las notificaciones. • **Semana epidemiológica (SE):** unidad de tiempo de la vigilancia, de domingo a sábado; el año tiene 52 o 53. • **Temporada:** semanas consecutivas con al menos la mitad de las notificaciones de la semana pico de ese año. Su inicio y su fin se expresan en SE. • **Pico:** semana con más notificaciones del año. • **Variación %:** (valor 2025 − valor 2019) ÷ valor 2019. • **Incidencia (tasa cada 100.000 hab.):** notificaciones ÷ población × 100.000; permite comparar provincias de distinto tamaño. • **Subnotificación:** casos que ocurrieron pero no fueron notificados. • **Prepandemia / pospandemia:** en este proyecto, 2019 / 2025.
Análisis de Datos	**Diccionario Semántico**	*¿Qué significa cada variable en el mundo real? (No solo el tipo de dato).* • **Provincia y departamento:** jurisdicción donde se registró la notificación; puede no coincidir con el lugar donde vive la persona. • **Año y semana epidemiológica:** momento en que se atendió y registró el caso, no necesariamente el día en que empezaron los síntomas.

		• **Evento:** tipo de cuadro según una definición clínica. No indica qué virus lo causó. En 2025 además dice si el paciente fue atendido en forma ambulatoria o internado. • **Grupo de edad:** rango de edad de la persona atendida; en menores de 2 años se mide en meses. Para el análisis se agrupó en 6 grupos: menores de 2 años, 2 a 4, 5 a 14, 15 a 44, 45 a 64 y 65 años o más. • **Cantidad de notificaciones (cantidad_casos):** personas atendidas que cumplen la definición del evento en esa semana, lugar y grupo de edad. Mide demanda registrada, no el total real de enfermos. • **Población (INDEC):** personas que viven en cada jurisdicción según el Censo 2022; es la base para comparar provincias. *El detalle técnico de cada variable está en el Diccionario de datos.*
	Factores Externos	*Lista de eventos que pueden alterar los valores (festivos, cambios de política, clima).No implica causalidad* *Eventos que pueden alterar los valores (no implican causalidad):* • **Pandemia de COVID-19 (2020-2022):** aislamiento, cambios en la circulación de virus y en la forma de consultar. • **Cambios en la notificación:** nuevas categorías en el SNVS 2.0 y jurisdicciones con sistemas propios o con cambios de carga. • **Vacunación:** vacuna contra el VSR para personas gestantes en el Calendario Nacional desde 2024, campañas antigripales anuales y vacunas contra COVID-19. • **Clima:** temperaturas bajas y estación fría. • **Calendario escolar:** inicio de clases y vacaciones de invierno. • **Circulación viral:** nuevas cepas de influenza y variantes de SARS-CoV-2. • **Acceso y demanda de atención:** cantidad de consultas, campañas de comunicación, brotes con alta difusión.
	Pregunta Análisis	*Enunciados claros de lo que se busca analizar a partir de los datos.*

Preguntas de análisis		• **1. ¿Qué cambió?** ¿El aumento de las notificaciones entre 2019 y 2025 fue parejo o se concentró en algunos eventos (ETI, neumonía y bronquiolitis) y grupos de edad? • **2. ¿Cuándo?** ¿La temporada de 2025 empezó, alcanzó su pico y terminó en las mismas semanas epidemiológicas que en 2019? • **3. ¿Dónde?** ¿Qué provincias presentan mayor incidencia de notificaciones en relación con su población, y cómo cambió entre 2019 y 2025?
	Aporte de valor	*¿Por qué es relevante responder esta pregunta? ¿Qué conocimiento puede aportar el análisis?* • **Pregunta 1:** permite saber si el aumento total se reparte por igual o se explica por eventos y edades en particular. Así se describe el comportamiento pospandemia de cada evento por separado, en lugar de tratar a las IRA como un todo. • **Pregunta 2:** describe si el calendario de la temporada respiratoria se mantuvo o se corrió, y si cambiaron su intensidad y su duración, algo que el total anual no muestra. • **Pregunta 3:** el ajuste por población muestra qué provincias tienen mayor incidencia más allá de su tamaño y si son las mismas antes y después de la pandemia. Además, pone en evidencia problemas de calidad en los datos, como la subnotificación.
	Alcance	*¿Hasta dónde se extiende el análisis? Por ejemplo: territorial, temporal, social, económico o poblacional.* • **Territorial:** nacional, 24 jurisdicciones, con análisis por provincia. • **Temporal:** 2019 (prepandemia) y 2025 (pospandemia), años completos, semanas epidemiológicas 1 a 52. Se excluyen 2018 (desde la SE 18) y 2026 (hasta la SE 36) por estar incompletos, y la SE 53 de 2025. No incluye 2020-2022. • **Poblacional:** notificaciones al SNVS, todas las edades (la bronquiolitis solo en menores de 2 años). • **Fuera del alcance:** casos que no consultaron, confirmación de laboratorio (qué virus), defunciones, datos por sexo e internaciones (solo una provincia notifica

		esa modalidad). La relación con la vacunación COVID-19 se exploró y se descartó: no se observó relación con la incidencia a nivel provincial.
	Enfoque	*¿Desde qué perspectiva se va a analizar la pregunta y qué se espera comprender a partir de los datos?* Descriptivo y comparativo, desde la perspectiva de la vigilancia en salud pública. Se comparan dos años completos en las mismas semanas epidemiológicas y se usan variaciones porcentuales y tasas cada 100.000 habitantes. Se espera comprender qué cambió (eventos y edades), cuándo (temporada) y dónde (provincias). El análisis no busca demostrar causas: los cambios observados se interpretan considerando los factores externos.
Observaciones	**Limitaciones Identificadas**	*Posibles sesgos o vacíos de información detectados en esta etapa.* • Notificaciones ≠ casos reales: hay subnotificación y depende de que las personas consulten. • Cambios en la forma de notificar entre períodos: Santa Fe (−90%) y CABA (−66%) muestran caídas que probablemente no se deben a la enfermedad; sus tasas no son comparables. • Categorías de evento distintas (3 en 2019 y 7 en 2025): hubo que agruparlas. • La modalidad "internados" solo la notifica Salta (4.490 notificaciones en 2025-2026), por lo que no es posible analizar internaciones a nivel nacional. • Las notificaciones sin edad especificada quedan fuera de la comparación por grupo de edad. • Faltan los años de pandemia (2020-2022): las versiones .xls del portal están cortadas en 65.535 filas. • Se usa la población del Censo 2022 para ambos años. • En 2018-2019 se sumaron filas con la misma clave (supuesto: una por establecimiento), a validar con la fuente. • Diagnóstico clínico: no se sabe qué virus causó cada caso. Tampoco hay datos por sexo ni socioeconómicos.

		• El lugar de notificación puede no coincidir con el de residencia.

Es importante que esta ficha sea completada en conjunto por el equipo de trabajo. Puede apoyarse en fuentes confiables del área (informes oficiales, documentación técnica, portales de datos) que ayuden a comprender el contexto y las variables analizadas. La ficha no es un documento estático: a medida que avanza el análisis y se comprende mejor la información, puede y debe actualizarse. El objetivo no es desarrollar un marco teórico extenso, sino construir una base clara que permita entender qué se está analizando.